Estilo UERJ

Simulado R01 Caderno

Simulado de revisão no formato da UERJ, montado a partir dos seus erros nos Simulados 1 a 4: quatro alternativas e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Mulher de 52 anos, em indução de leucemia mieloide aguda, tem duas reações febris não hemolíticas registradas em transfusões anteriores de plaquetas. Hoje, após pré-medicação com paracetamol, recebe uma unidade de plaquetas por aférese armazenada há 5 dias. Aos 20 minutos de infusão, apresenta calafrios intensos e a temperatura sobe de 37,0 para 39,6 °C; PA 82/44 mmHg, FC 128 bpm, SpO2 95% em ar ambiente, sem urticária, sem sibilos, sem dor lombar. A infusão foi interrompida e a identificação da bolsa confere. Além da expansão volêmica, a conduta mais adequada é:

A) Hemoculturas da paciente e da bolsa e antibiótico amplo

B) Antitérmico e reiniciar a infusão mais lenta

C) Coombs direto e diurese forçada com salina

D) Adrenalina intramuscular e anti-histamínico

---

2 Mulher de 31 anos, com lúpus eritematoso sistêmico há 4 anos (artrite, fotossensibilidade, FAN 1:640 homogêneo, anti-DNA nativo positivo), em uso de hidroxicloroquina, teve há 10 dias afasia de expressão súbita; a RM mostrou infarto em território da artéria cerebral média esquerda. Ecocardiograma transesofágico sem trombos e sem vegetações, Holter sem fibrilação atrial, Doppler de carótidas normal. Livedo racemosa em membros. Plaquetas 98.000/mm³, C3 e C4 normais, urina sem alterações, sem artrite ou lesões cutâneas ativas. Anticoagulante lúpico, anticardiolipina IgG em título alto e anti-beta2-glicoproteína I positivos, confirmados após 12 semanas. A conduta mais adequada para a prevenção secundária é:

A) Varfarina com RNI-alvo de 2 a 3

B) Rivaroxabana em dose plena

C) Ácido acetilsalicílico isolado

D) Pulsoterapia com ciclofosfamida

---

3 Mulher de 52 anos fez TC de abdome por cólica renal, que mostrou cálculo ureteral já eliminado e nódulo adrenal esquerdo de 2,6 cm, homogêneo, de contornos regulares, com densidade de 16 UH na fase sem contraste. Na fase tardia, o washout absoluto foi de 68%. Não tem história de neoplasia. É normotensa, sem fraqueza ou hipocalemia. Cortisol após 1 mg de dexametasona: 1,2 µg/dL; metanefrinas livres plasmáticas normais; potássio 4,3 mEq/L. A conduta mais adequada é:

A) Adrenalectomia laparoscópica

B) Nenhum novo exame de imagem

C) Biópsia percutânea guiada por TC

D) PET-CT com FDG

---

4 Homem de 57 anos, com diabetes tipo 2 e obesidade, acompanha esteatose hepática metabólica. Nunca teve ascite, sangramento ou encefalopatia. Exame físico sem circulação colateral e sem esplenomegalia palpável; PA 132/80 mmHg, FC 74 bpm. Bilirrubina 0,9 mg/dL, albumina 4,2 g/dL, INR 1,1, plaquetas 168.000/mm³. Elastografia hepática transitória de 13,8 kPa, com exame confiável. O clínico que o encaminhou já pediu endoscopia digestiva alta para rastrear varizes e sugeriu iniciar propranolol. A conduta mais adequada para a hipertensão portal neste momento é:

A) Elastografia e plaquetas anuais, sem endoscopia

B) Endoscopia de rastreio e conduta pelo achado

C) Carvedilol sem endoscopia de rastreio

D) Propranolol e endoscopia em um ano

---

5 Mulher de 24 anos é trazida 1 hora após ingerir, intencionalmente, todos os comprimidos que o irmão recebeu na unidade de saúde para tratar infecção latente pela tuberculose, cerca de 30 comprimidos de 300 mg. Na chegada tem crise tônico-clônica generalizada, que se repete após duas doses de diazepam 10 mg IV. Nunca teve crise antes; o pai tem epilepsia em uso de carbamazepina. PA 128 x 80 mmHg, FC 122 bpm, Tax 37,8 °C. Gasometria: pH 7,08, bicarbonato 8 mEq/L, lactato 11 mmol/L. Glicemia 140 mg/dL, sódio 139 mEq/L, cálcio e magnésio normais. A conduta imediata e a conduta após a alta, em relação à anticrise, são, respectivamente:

A) Piridoxina IV / sem anticrise de manutenção

B) Piridoxina IV / levetiracetam por 6 meses

C) Fenitoína IV / fenitoína por 6 meses

D) Fenobarbital IV / sem anticrise de manutenção

---

6 Mulher de 52 anos, com transtorno bipolar estável há 14 anos em uso de carbonato de lítio (litemia de 0,7 mEq/L), queixa-se de poliúria de cerca de 5 litros por dia e noctúria há 2 anos. Duas tentativas de troca do estabilizador terminaram em internação por mania, e a psiquiatra pede para manter o lítio. PA 124/78 mmHg, sem edema. Sódio 145 mEq/L, potássio 4,1 mEq/L, cálcio 9,6 mg/dL, glicemia 92 mg/dL, creatinina 1,0 mg/dL. Osmolalidade urinária de 120 mOsm/kg, que chega a 180 após restrição hídrica e a 195 após desmopressina. A medida mais adequada para reduzir a poliúria é:

A) Associar amilorida

B) Associar hidroclorotiazida

C) Desmopressina intranasal

D) Restrição hídrica orientada

---

7 Num pronto-socorro, no pico de uma epidemia de influenza, 60% dos adultos que chegam com febre e tosse há menos de 48 horas têm influenza confirmada por RT-PCR. Um teste rápido antigênico para influenza tem, nessa população, sensibilidade de 80% e especificidade de 95%. Um paciente desse grupo tem teste rápido negativo. A probabilidade de que ele tenha influenza, mesmo com o teste negativo, é mais próxima de:

A) 5%

B) 20%

C) 24%

D) 40%

---

8 Homem de 58 anos vive com HIV há 9 anos, com carga viral indetectável nos últimos 4 anos em uso de tenofovir, lamivudina e dolutegravir, que toma em jejum, ao acordar. Há 4 meses, após densitometria com osteoporose e anemia ferropriva por hemorroidas, passou a tomar carbonato de cálcio 1.250 mg, colecalciferol e sulfato ferroso, todos no mesmo horário, também em jejum. Nega falhas de dose, e a farmácia confirma a retirada mensal regular. Carga viral agora: 3.900 cópias/mL, confirmada em nova amostra; CD4 estável em 610 células/mm³. A causa mais provável da viremia é:

A) Falta de adesão não admitida

B) Resistência adquirida à integrase

C) Quelação do dolutegravir pelos cátions

D) Indução enzimática pelo colecalciferol

---

9 Homem de 58 anos, em hemodiálise há 6 anos, faltou às duas últimas sessões. Há 5 dias foi ao pronto-socorro por dor torácica que piorava ao deitar e melhorava ao sentar inclinado para a frente; foi auscultado atrito pericárdico e recebeu alta com orientação de diálise. Hoje chega dispneico, com PA 76 × 50 mmHg, FC 126 bpm e jugulares distendidas, e perde a consciência na triagem. Não há pulso central. O monitor mostra ritmo regular com QRS estreito a 128 bpm. A gasometria colhida durante as compressões mostra potássio de 6,1 mEq/L. Murmúrio vesicular presente e simétrico. A causa mais provável da parada é:

A) Tromboembolismo pulmonar

B) Tamponamento cardíaco

C) Hipovolemia

D) Hipercalemia

---

10 Mulher de 29 anos, com macroprolactinoma de 14 mm tratado com cabergolina por 2 anos, engravidou quando a lesão media 9 mm, sem contato com o quiasma. Conforme orientação, suspendeu a cabergolina na quinta semana. Com 26 semanas, refere cefaleia frontal progressiva há 10 dias e esbarra em objetos à sua lateral. Campimetria computadorizada: hemianopsia temporal bilateral. Ressonância de sela sem gadolínio: lesão de 16 mm, com extensão suprasselar e contato com o quiasma óptico, sem sinais de hemorragia. Prolactina de 310 ng/mL. Gestação sem intercorrências, ultrassonografia obstétrica normal. A conduta inicial mais adequada é:

A) Cirurgia transesfenoidal na mesma semana

B) Antecipar o parto por cesariana

C) Seguir com campimetria mensal

D) Reintroduzir o agonista dopaminérgico

---

11 Mulher de 32 anos, com dor difusa, cansaço e sono não reparador há 1 ano, foi encaminhada ao reumatologista por FAN positivo. Nega fotossensibilidade, úlceras orais, Raynaud, artrite, olho seco, febre ou perda de peso. Mãe com lúpus. Exame físico com múltiplos pontos dolorosos à palpação, sem sinovite, sem lesões cutâneas e sem alterações à ausculta. FAN 1:640 com padrão nuclear pontilhado fino denso; anti-DFS70 positivo; anti-DNA nativo, anti-Sm, anti-Ro, anti-La e anti-RNP negativos; C3 e C4 normais. Hemograma, VHS, PCR, creatinina, CK, TSH e urina tipo 1 normais. A conduta mais adequada em relação ao FAN é:

A) Hidroxicloroquina 400 mg/dia

B) Prednisona 10 mg/dia

C) Biópsia de glândula salivar menor

D) Tranquilizar, sem imunossupressão

---

12 Mulher de 42 anos, com asma leve na infância, ficou 16 dias intubada por pneumonia grave há 5 meses. Há 2 meses tem dispneia progressiva aos esforços e ruído respiratório audível tanto na inspiração quanto na expiração, sem melhora com formoterol-budesonida prescritos como asma. Nega rouquidão e disfagia. Ao exame, estridor bifásico em repouso que se acentua com a hiperventilação, sibilância difusa ausente à ausculta dos campos pulmonares, SpO2 97%. A TC do pescoço e do tórax mostra estenose concêntrica, rígida, de 1,5 cm de extensão, na traqueia cervical logo abaixo da cricoide, com luz residual de 6 mm, sem colapso dinâmico nas fases do ciclo respiratório. Na curva fluxo-volume, o achado esperado é:

A) Achatamento isolado da alça inspiratória

B) Achatamento isolado da alça expiratória

C) Concavidade expiratória com volumes altos

D) Achatamento das alças inspiratória e expiratória

---

13 Homem de 66 anos, com leucemia linfocítica crônica estádio A de Binet diagnosticada há 6 anos e nunca tratada, refere há 6 semanas febre vespertina, sudorese noturna e perda de 7 kg. Notou um linfonodo cervical esquerdo que passou de 2 para 6 cm nesse período, endurecido e indolor; os demais linfonodos estão estáveis, em torno de 1,5 cm. Temperatura 38,1 °C, baço a 3 cm do rebordo. Hemograma: hemoglobina 12,4 g/dL, leucócitos 24.000/mm³ com 78% de linfócitos pequenos (estáveis em relação ao último ano), plaquetas 160.000/mm³. LDH 1.120 U/L (até 250), cálcio 10,9 mg/dL. Hemoculturas negativas e radiografia de tórax normal. O próximo exame mais adequado é:

A) Biópsia excisional guiada por PET-CT

B) Nova imunofenotipagem do sangue periférico

C) Pesquisa de del(17p) e mutação de TP53

D) Biópsia de medula óssea com mielograma

---

14 Homem de 69 anos foi diagnosticado há 2 anos com 'doença de Parkinson' e usa levodopa/benserazida 250 mg 4 vezes ao dia, sem melhora perceptível. A esposa relata quedas para trás desde o primeiro ano dos sintomas, várias com fratura de punho, além de fala arrastada, engasgos com líquidos e lentidão para ler o jornal. Exame: rigidez de pescoço e tronco maior que nos membros, sem tremor de repouso, face com olhar fixo e testa franzida, piscamento raro. Ao se sentar, deixa-se cair na cadeira. PA 128 × 80 mmHg deitado e 124 × 78 mmHg em pé. Controle urinário normal. O achado ao exame mais provável neste paciente é:

A) Paralisia do olhar vertical para baixo

B) Tremor de repouso assimétrico que melhora com a levodopa

C) Estridor noturno com hipotensão ortostática grave

D) Apraxia e mioclonia restritas a um membro superior

---

15 Homem de 27 anos, natural de Montes Claros (MG), mora em área periurbana onde vários cães da vizinhança foram sacrificados no último ano. Há 10 semanas tem febre diária, emagrecimento de 9 kg e aumento do volume abdominal. Exame: emagrecido e pálido, baço palpável a 12 cm do rebordo costal e fígado a 4 cm. Hemoglobina 7,8 g/dL, leucócitos 1.900/mm³ (neutrófilos 800/mm³), plaquetas 71.000/mm³, sem blastos no sangue periférico; albumina 2,6 g/dL e globulinas 5,4 g/dL. Anti-HIV não reagente. Para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento, o exame inicial mais adequado é:

A) Aspirado de medula óssea

B) Teste imunocromatográfico rK39

C) Punção aspirativa esplênica

D) Biópsia hepática percutânea

---

16 Homem de 52 anos, com cirrose alcoólica e abstinente há 6 meses, é admitido com hematêmese volumosa. Recebeu terlipressina, ceftriaxona e transfusão restritiva; a endoscopia, feita em 6 horas, mostrou varizes esofágicas de grosso calibre, uma delas com sangramento ativo em jato no momento do exame, tratada com ligadura elástica com hemostasia. Child-Pugh de 8 pontos (bilirrubina 2,4 mg/dL, albumina 3,0 g/dL, ascite discreta), MELD 14. Sem encefalopatia, sem hepatocarcinoma, creatinina 1,0 mg/dL; ecocardiograma com função ventricular normal e pressão sistólica pulmonar estimada em 28 mmHg. Nas primeiras 24 horas permanece estável. A conduta mais adequada nas próximas 48 horas é:

A) Terlipressina por 5 dias e alta

B) TIPS com prótese recoberta

C) Carvedilol e nova ligadura em 2 semanas

D) Balão esofágico por 24 horas

---

17 Homem de 71 anos, com doença de Parkinson há 9 anos, teve quedas repetidas por tontura ao levantar. Há 3 meses o neurologista acrescentou um comprimido matinal para a pressão baixa, além de meias elásticas. Agora tem cefaleia matinal e edema maleolar; PA deitado de 178/96 mmHg e em pé de 138/82 mmHg. Potássio 2,9 mEq/L, bicarbonato 31 mEq/L, sódio 145 mEq/L, creatinina 1,0 mg/dL. Aldosterona plasmática 3 ng/dL (referência 4 a 31) e atividade de renina 0,1 ng/mL/h, com relação aldosterona/renina de 30. Cortisol matinal 14 µg/dL. A causa mais provável do quadro é:

A) Hiperaldosteronismo primário

B) Mineralocorticoide exógeno

C) Síndrome de Liddle

D) Hipertensão renovascular

---

18 Homem de 66 anos teve infarto anterior extenso há 3 anos, tratado com angioplastia da descendente anterior. Desde então tem insuficiência cardíaca e, há 5 meses, usa sacubitril-valsartana 97/103 mg de 12/12 horas, bisoprolol 10 mg/dia, espironolactona 25 mg/dia e dapagliflozina 10 mg/dia, todos nas doses máximas toleradas. Refere dispneia apenas aos grandes esforços, como subir dois lances de escada, sem internações no último ano. PA 108 × 68 mmHg, FC 62 bpm, sem congestão. Ecocardiograma de controle: FE de 30%, igual à do ano anterior. Cintilografia sem isquemia residual. ECG: ritmo sinusal com bloqueio de ramo direito, QRS de 142 ms. Potássio 4,6 mEq/L, creatinina 1,2 mg/dL. A conduta mais adequada para este paciente é:

A) Manter apenas o tratamento clínico

B) Ressincronizador com desfibrilador

C) Ressincronizador sem desfibrilador

D) Cardiodesfibrilador implantável isolado

---

19 Mulher de 72 anos, há 5 semanas com dor e rigidez matinal de 2 horas nos ombros, no pescoço e na cintura pélvica, que a impedem de vestir-se sozinha. Nega alteração visual, febre ou perda de peso relevante. À anamnese dirigida, refere dor nos músculos da mandíbula ao mastigar carne, que a obriga a pausar a refeição, e cefaleia temporal discreta. Ao exame, dor à mobilização dos ombros, sem sinovite periférica; artérias temporais com pulso presente, sem espessamento ou dor à palpação. Fundo de olho normal. VHS 88 mm/h, PCR 54 mg/L, hemoglobina 10,9 g/dL. O diagnóstico e a dose inicial de prednisona mais adequados são, respectivamente:

A) Polimialgia isolada / 12,5 a 25 mg

B) Arterite de células gigantes / 40 a 60 mg

C) Polimialgia isolada / 40 a 60 mg

D) Arterite de células gigantes / pulso de 1 g

---

20 Homem de 61 anos, com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, usa metformina 2 g/dia e, há 3 meses, um comprimido acrescentado pelo cardiologista que melhorou a falta de ar e baixou a glicemia; desde então teve dois episódios de balanopostite por cândida. Há 4 dias tem vômitos e diarreia, come pouco e manteve todos os remédios. Está taquipneico, com respiração profunda, PA 104 × 68 mmHg, FC 112 bpm, mucosas secas. Glicemia 196 mg/dL; pH 7,11; bicarbonato 8 mEq/L; pCO2 22 mmHg; sódio 136 mEq/L; cloro 100 mEq/L; potássio 4,6 mEq/L; lactato 1,6 mmol/L; beta-hidroxibutirato 5,8 mmol/L; creatinina 1,4 mg/dL. Além de suspender os orais e hidratar com solução salina, a conduta mais adequada é:

A) Insulina venosa contínua com soro glicosado

B) Hidratação isolada até a glicemia subir

C) Bicarbonato venoso e hemodiálise

D) Insulina subcutânea conforme glicemia capilar

---

21 Mulher de 64 anos, com diabetes tipo 2 há 11 anos em uso de metformina 2 g/dia e omeprazol há 8 anos, relata cansaço há 4 meses e parestesias nos pés atribuídas à neuropatia diabética. Afebril, PA 122/70 mmHg, mucosas descoradas e subictéricas, sem déficit focal. Hemoglobina 6,9 g/dL, VCM 116 fL, leucócitos 3.100/mm³, plaquetas 62.000/mm³, esquizócitos 3%, reticulócitos 0,8%. LDH 3.400 U/L, bilirrubina indireta 2,6 mg/dL, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo. Creatinina 0,9 mg/dL, coagulograma normal. A residente sugere iniciar plasmaférese pela microangiopatia. O próximo exame mais adequado é:

A) Cariótipo da medula óssea

B) Atividade de ADAMTS13

C) Pesquisa de clone HPN

D) Cobalamina e ácido metilmalônico

---

22 Mulher de 54 anos, com carcinoma de mama luminal A tratado há 6 anos, apresenta dor dorsal há 3 semanas, que piora ao sentar e ao se virar no leito e alivia deitada imóvel. Há 18 horas tem fraqueza nas pernas e dificuldade para urinar. Exame: força grau 4 nos membros inferiores, nível sensitivo em T11, reflexos patelares vivos. ECOG prévio 0, sem outras metástases viscerais; expectativa de vida estimada acima de 1 ano. RM: metástase lítica única em T10, com colapso do corpo vertebral maior que 50%, cifose segmentar e subluxação, acometimento bilateral dos elementos posteriores e compressão medular (SINS 15). Recebeu dexametasona intravenosa. Além do corticoide, a conduta mais adequada é:

A) Radioterapia isolada em dose única

B) Hormonioterapia e reavaliação em 2 semanas

C) Radioterapia fracionada isolada

D) Estabilização cirúrgica e depois radioterapia

---

23 Mulher de 44 anos vive com HIV desde 2019, em TARV com carga viral indetectável e CD4 de 620 células/mm³. Na consulta anual, conta que teve tosse prolongada com perda de peso aos 20 anos, quando morava com um tio que tratava tuberculose; ela nunca foi investigada nem tratada. Hoje está assintomática: sem tosse, febre, sudorese ou perda de peso. Prova tuberculínica: 2 mm. Radiografia de tórax: estrias fibróticas e nódulos calcificados no ápice direito, sem cavidade e sem infiltrado novo. Baciloscopia e teste rápido molecular de escarro induzido negativos. A conduta mais adequada é:

A) Tratar a infecção latente agora

B) Repetir a prova tuberculínica em 1 ano

C) Solicitar IGRA antes de decidir

D) Iniciar esquema RHZE por 6 meses

---

24 Mulher de 31 anos, não tabagista, procura atendimento por dor e edema nos dois tornozelos há 3 semanas, com febre baixa e nódulos dolorosos, vermelho-violáceos, nas faces anteriores das pernas. Está preocupada porque a irmã teve linfoma de Hodgkin aos 28 anos. Nega sudorese noturna, prurido e perda de peso; nega tosse e dispneia. Ao exame, periartrite bilateral dos tornozelos, sem linfonodos periféricos palpáveis, sem hepatoesplenomegalia, ausculta pulmonar normal. Hemograma normal, VHS 58 mm/h, cálcio 9,8 mg/dL. Radiografia de tórax: alargamento hilar bilateral e simétrico, com linfonodomegalia paratraqueal direita, parênquima normal. Prova tuberculínica 0 mm. O próximo passo mais adequado é:

A) Biópsia de um nódulo cutâneo

B) Ultrassonografia endobrônquica com punção

C) Seguimento clínico, sem biópsia

D) PET-CT com FDG

---

25 Homem de 34 anos procura atendimento por palpitações e um episódio de pré-síncope há 2 semanas. Conta que há anos tem dificuldade para soltar a maçaneta da porta depois de segurá-la com força, e que fez cirurgia de catarata bilateral aos 31 anos. O pai morreu subitamente aos 49 anos; um primo foi rotulado como portador de 'distrofia muscular' na infância. Ao exame: calvície frontal, ptose bilateral discreta, atrofia dos músculos temporais e dos esternocleidomastóideos, fraqueza distal nas mãos e nos pés, panturrilhas de volume normal. Ao percutir a eminência tenar, o polegar fica aduzido por alguns segundos. PA 118 × 74 mmHg, FC 58 bpm, ausculta cardíaca sem sopros. CK 290 U/L (referência até 190). O achado eletrocardiográfico mais provável neste paciente é:

A) Intervalo PR curto com onda delta

B) Intervalo QT longo com onda U proeminente

C) Onda R ampla em V1 com Q lateral profunda

D) Intervalo PR longo com QRS alargado

---

26 Homem de 63 anos tem, há 10 meses, fraqueza e atrofia progressivas nas mãos, cãibras frequentes e marcha rígida. RM de coluna cervical: estenose em C5-C6 com compressão medular e hipersinal intramedular em T2 nesse nível; a cirurgia descompressiva foi agendada. Exame: atrofia de interósseos e tenares bilateral, hiper-reflexia nos quatro membros com sinal de Babinski bilateral, fasciculações em ambos os peitorais e na parede abdominal, sensibilidade tátil, dolorosa e vibratória normal, sem nível sensitivo. Controle esfincteriano preservado. Fala e deglutição normais. Antes da cirurgia, foi pedida eletroneuromiografia. O achado que, isoladamente, mais indica que a compressão cervical não explica o quadro é:

A) Desnervação restrita aos miótomos C5 e C6

B) Redução da amplitude sensitiva do mediano

C) Desnervação no genioglosso e no tronco

D) Bloqueio de condução motora multifocal

---

27 Homem de 76 anos, com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e doença renal crônica estágio 3b, usa carvedilol 25 mg duas vezes ao dia, enalapril e espironolactona. Há 3 dias tem diarreia e come pouco. Chega tonto e sonolento; PA 78/44 mmHg, FC 34 bpm, extremidades frias. ECG: ritmo juncional, sem ondas P visíveis, QRS de 136 ms e ondas T apiculadas. Potássio 6,7 mEq/L, creatinina 3,1 mg/dL (basal 1,8), glicemia 104 mg/dL, bicarbonato 18 mEq/L. A residente já separou atropina e prepara as pás do marcapasso transcutâneo. A primeira medida a ser tomada é:

A) Atropina 1 mg intravenosa

B) Marcapasso transcutâneo

C) Gluconato de cálcio intravenoso

D) Hemodiálise de urgência

---

28 Homem de 36 anos, cujo irmão foi operado aos 40 anos de câncer de tireoide, tem nódulo tireoidiano de 2,1 cm à direita. A punção aspirativa mostrou células fusiformes com estroma amiloide e imunocitoquímica positiva para calcitonina. Calcitonina sérica 860 pg/mL, CEA 42 ng/mL. Pesquisa do proto-oncogene RET: mutação no códon 634. Refere episódios de cefaleia com sudorese e palpitações, 2 vezes por mês. PA 154 × 96 mmHg, FC 92 bpm. Cálcio 11,0 mg/dL (8,5 a 10,2), PTH 98 pg/mL (15 a 65). Metanefrinas livres plasmáticas cinco vezes acima do limite superior. TC de abdome: massa adrenal esquerda de 3,4 cm, com 38 UH na fase sem contraste. A primeira cirurgia a ser realizada é:

A) Tireoidectomia e adrenalectomia simultâneas

B) Paratireoidectomia com exploração bilateral

C) Adrenalectomia após alfabloqueio

D) Tireoidectomia total com esvaziamento central

---

29 Mulher de 63 anos, com diabetes tipo 2 há 12 anos em uso de metformina e empagliflozina, hipertensa, IMC de 33 kg/m², consome uma taça de vinho por semana. Ultrassonografia de rotina mostrou esteatose moderada, fígado de contornos regulares e baço de 11 cm. Sorologias para hepatites B e C negativas, ferritina 210 ng/mL. Exames: AST 36 U/L (até 40), ALT 24 U/L (até 41), GGT 58 U/L, albumina 4,1 g/dL, INR 1,0, plaquetas 128.000/mm³. Assintomática, sem estigmas de hepatopatia ao exame. A faixa de risco de fibrose avançada pelo FIB-4 e a conduta mais adequada são, respectivamente:

A) Baixa / repetir o FIB-4 em 2 anos

B) Intermediária / elastografia hepática

C) Alta / elastografia e hepatologista

D) Não aplicável / sem investigação adicional

---

30 Mulher de 24 anos teve lúpus diagnosticado há 2 meses por artrite, alopecia e leucopenia, e usa prednisona 20 mg/dia e hidroxicloroquina. Há 6 dias tem febre diária de 39,5 °C, mal-estar intenso e confusão leve. Ao exame, hepatoesplenomegalia e linfonodos cervicais pequenos. Hemoglobina 7,9 g/dL, leucócitos 1.900/mm³, plaquetas 54.000/mm³, sem esquizócitos no esfregaço. AST 210 U/L, ALT 160 U/L, LDH 1.400 U/L, ferritina 14.800 ng/mL, triglicerídeos 390 mg/dL, fibrinogênio 105 mg/dL (200 a 400), VHS 12 mm/h (era 70 mm/h há 1 mês). C3 e anti-DNA nativo estáveis em relação ao diagnóstico. Hemoculturas e urocultura negativas. O diagnóstico mais provável é:

A) Síndrome de ativação macrofágica

B) Atividade hematológica do lúpus

C) Púrpura trombocitopênica trombótica

D) Sepse com coagulação intravascular

---

31 Homem de 34 anos, garimpeiro em Roraima, chega ao Rio de Janeiro com febre em picos a cada 48 horas há 9 dias. Está lúcido, aceita a dieta e não vomita. PA 108/66 mmHg, FC 104 bpm, FR 18 irpm, SatO2 96% em ar ambiente. Gota espessa: trofozoítos ameboides e esquizontes com 16 merozoítos, em hemácias aumentadas com granulações de Schüffner; parasitemia de 8.000/mm³. Hemoglobina 6,1 g/dL, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 1,1 mg/dL, bilirrubina total 2,0 mg/dL, glicemia 98 mg/dL, lactato 1,4 mmol/L. A espécie e o tratamento antimalárico inicial são, respectivamente:

A) P. falciparum / artesunato intravenoso

B) P. vivax / cloroquina e primaquina

C) P. falciparum / artemeter-lumefantrina oral

D) P. vivax / artesunato intravenoso

---

32 Homem de 47 anos chega com dispneia progressiva há 3 dias, cefaleia e confusão mental. PA 128/76 mmHg, FC 112 bpm, FR 28 irpm, SpO2 89% em ar ambiente, temperatura 37,8 °C. Fundoscopia com hemorragias retinianas e veias tortuosas. Radiografia de tórax com infiltrado intersticial bilateral discreto. Hemograma: leucócitos 186.000/mm³ com 82% de blastos mieloides, hemoglobina 6,8 g/dL, plaquetas 18.000/mm³. Creatinina 1,6 mg/dL, potássio 4,9 mEq/L, ácido úrico 9,8 mg/dL, fibrinogênio 290 mg/dL. Sem sangramento ativo. Quanto às hemácias e à redução da carga leucêmica, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Transfundir 2 unidades / aguardar o mielograma

B) Transfundir 2 unidades / leucaférese isolada

C) Adiar hemácias / hidroxiureia e indução

D) Transfundir 2 unidades / hidroxiureia e indução

---

33 Uma mulher de 81 anos, que pesa 58 kg, tem fibrilação atrial permanente, hipertensão e diabetes tipo 2. Usa losartana, anlodipino e metformina. Nega sangramentos prévios, quedas, uso de anti-inflamatórios ou de antiagregantes. PA 132 × 78 mmHg, FC 76 bpm. Hemoglobina 12,8 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, TGO e TGP normais. Creatinina 1,1 mg/dL, depuração estimada pela fórmula de Cockcroft-Gault de 37 mL/min. O médico assistente opta por apixabana. A dose mais adequada é:

A) 5 mg de 12 em 12 horas

B) 5 mg uma vez ao dia

C) 2,5 mg uma vez ao dia

D) 2,5 mg de 12 em 12 horas

---

34 Homem de 57 anos, etilista de cerca de 15 doses por dia, hipertenso e com fibrilação atrial sem anticoagulação, é trazido de um bar por vertigem rotatória súbita e contínua há 5 horas, vômitos e incapacidade de ficar de pé. Está alerta e orientado, responde com coerência. Alcoolemia 40 mg/dL, glicemia 104 mg/dL. Movimentos oculares sem limitação em nenhuma direção. Nistagmo horizontal que bate para a direita no olhar à direita e para a esquerda no olhar à esquerda; impulso cefálico sem sacada corretiva para ambos os lados; desvio vertical de um olho ao teste de cobertura alternada. Dismetria apendicular à direita. Força e sensibilidade normais. PA 178 × 100 mmHg. O diagnóstico mais provável é:

A) Encefalopatia de Wernicke

B) Infarto cerebelar

C) Intoxicação alcoólica aguda

D) Neurite vestibular

---

35 Homem de 67 anos, tabagista de 50 maços-ano, com DPOC leve (VEF1 72% do previsto, DLCO 70%), teve achado de nódulo sólido de 2,2 cm no lobo superior direito, de contornos espiculados, que não existia em TC de 18 meses antes. PET-CT: captação com SUV máximo de 7,8 no nódulo, sem captação mediastinal ou à distância; RM de crânio normal. Foi feita biópsia transtorácica guiada por TC, com dois fragmentos que mostram parênquima com fibrose e infiltrado inflamatório crônico inespecífico, sem células neoplásicas e sem granulomas; culturas negativas. Está assintomático, sem febre, ECOG 0, e a avaliação cardiológica liberou cirurgia. A conduta mais adequada é:

A) Ressecção cirúrgica anatômica

B) TC de tórax em 3 meses

C) Repetir a biópsia transtorácica

D) Radioterapia estereotáxica

---

36 Mulher de 38 anos, com boca e olhos secos há 3 anos, acorda com fraqueza flácida dos quatro membros, sem alteração sensitiva. Nega vômitos, diarreia, diuréticos ou laxantes. PA 112/70 mmHg. Exames: potássio 2,3 mEq/L, sódio 139 mEq/L, cloro 116 mEq/L, bicarbonato 13 mEq/L, glicemia 88 mg/dL, fosfato sérico 3,4 mg/dL, ácido úrico 4,8 mg/dL. Urina sem glicosúria e sem aminoacidúria, pH urinário de 6,8 em jejum, ânion gap urinário de +28. Ultrassonografia com nefrocalcinose medular bilateral. O diagnóstico mais provável é:

A) Acidose tubular renal proximal

B) Acidose tubular renal distal

C) Acidose tubular renal tipo 4

D) Síndrome de Gitelman

---

37 Homem de 64 anos, com asma de início há 3 anos, notou aumento indolor e bilateral das glândulas submandibulares há 1 ano. Encaminhado por creatinina de 2,4 mg/dL (era 1,0 há 8 meses). Urina com sedimento pobre, sem hematúria dismórfica; proteinúria 0,6 g/24h. TC de abdome: múltiplas lesões corticais hipodensas, arredondadas, nos dois rins. C3 48 mg/dL (90 a 180), C4 5 mg/dL (10 a 40), FAN 1:160 nuclear homogêneo, anti-DNA nativo e ANCA negativos, eosinófilos 900/mm³, IgE total elevada. Biópsia renal: nefrite tubulointersticial rica em plasmócitos, com fibrose estoriforme, e glomérulos sem depósitos imunes à imunofluorescência. O diagnóstico mais provável é:

A) Nefrite lúpica

B) Sarcoidose renal

C) Doença relacionada à IgG4

D) Granulomatose eosinofílica com poliangeíte

---

38 Mulher de 41 anos procura atendimento por palpitações, insônia e perda de 4 kg em 3 meses. A mãe e a irmã mais nova têm doença de Graves, e a irmã fez descompressão orbitária no ano passado. Ao exame, FC 108 bpm, tremor fino de extremidades, pele quente e úmida, sem proptose, sem retração palpebral e sem lesões pré-tibiais; nódulo endurecido de cerca de 3 cm no lobo direito, sem sopro tireoidiano. TSH abaixo de 0,01 mUI/L, T4 livre 2,6 ng/dL (0,9 a 1,7), T3 total 260 ng/dL (80 a 180). TRAb de terceira geração negativo. Cintilografia com iodo-123: captação de 24 horas de 36%, concentrada em área única correspondente ao nódulo, com o restante do parênquima pouco visualizado. O diagnóstico mais provável é:

A) Bócio multinodular tóxico

B) Adenoma tóxico

C) Doença de Graves

D) Tireoidite indolor

---

39 Homem de 72 anos, com adenocarcinoma de próstata resistente à castração e metástases ósseas difusas, está internado em cuidados paliativos. Usa morfina oral de liberação imediata, 20 mg de 4/4 horas, com resgates, há 3 semanas. Nos últimos 4 dias, a dor ficou mais difusa e passou a doer ao simples toque do lençol; a família pediu aumento da dose, e o resgate foi usado 7 vezes ontem. Está sonolento, com abalos musculares rápidos e involuntários nos membros e alucinações visuais à noite. Pupilas mióticas, FR 14 irpm. Creatinina 3,6 mg/dL (era 1,4 há 1 mês), por obstrução ureteral bilateral pela doença. Cálcio corrigido 9,4 mg/dL, sódio 138 mEq/L, glicemia 104 mg/dL. Em relação à analgesia, a conduta mais adequada é:

A) Aumentar a morfina em 50%

B) Trocar a morfina por fentanil

C) Manter a morfina e associar haloperidol

D) Trocar a morfina por codeína

---

40 Mulher de 46 anos, usuária de DIU de cobre há 11 anos sem troca, procura atendimento por dor em baixo ventre há 4 meses, perda de 7 kg e febre baixa vespertina. Ao exame, massa endurecida, de consistência lenhosa, em fossa ilíaca direita, aderida à parede abdominal, com um orifício fistuloso cutâneo que drena secreção com pequenos grânulos amarelados. TC: massa anexial direita de 7 cm que infiltra a parede abdominal e o ceco, atravessando planos, sem linfonodomegalia retroperitoneal. CA-125 de 88 U/mL (referência: até 35). A biópsia percutânea mostra microabscessos com filamentos Gram-positivos ramificados, não álcool-ácido resistentes à coloração de Ziehl-Neelsen modificada, sem células neoplásicas. Além da retirada do DIU, a conduta mais adequada é:

A) Penicilina em dose alta por 6 a 12 meses

B) Ceftriaxona e metronidazol por 14 dias

C) Sulfametoxazol-trimetoprima por 6 meses

D) Histerectomia com anexectomia e omentectomia

---

41 Mulher de 44 anos, 6 semanas após pancreatite aguda biliar necrosante, retorna ao ambulatório. Está em casa, alimenta-se por via oral sem náuseas nem saciedade precoce, está afebril há 4 semanas, usa apenas dipirona eventual e o peso está estável. Abdome com desconforto leve à palpação profunda do epigástrio, sem massa palpável; PA 118/74 mmHg, FC 76 bpm. Leucócitos 7.800/mm³, PCR 6 mg/L, bilirrubinas e enzimas canaliculares normais. TC: coleção de 11 cm na cauda do pâncreas, com parede bem definida e conteúdo heterogêneo com debris, sem gás, sem compressão gástrica, duodenal ou biliar. O cirurgião sugere drenagem pelo tamanho. A conduta mais adequada para a coleção é:

A) Drenagem endoscópica com prótese metálica

B) Necrosectomia cirúrgica videoassistida

C) Drenagem percutânea guiada por TC

D) Acompanhamento clínico sem drenagem

---

42 Homem de 34 anos, pardo, internado por pneumonia comunitária, recebe ceftriaxona e azitromicina. No terceiro dia apresenta urina cor de coca-cola, icterícia e queda da hemoglobina de 14,2 para 8,1 g/dL. Sem uso de outras medicações, sem transfusões prévias, sem trombose. Esfregaço: hemácias com áreas de palidez excêntrica, algumas com a hemoglobina retraída para um lado, sem esferócitos em quantidade relevante. Coombs direto negativo, LDH 1.460 U/L, haptoglobina indetectável. Atividade de G6PD normal, colhida no quinto dia, com reticulócitos de 14%. Plaquetas e leucócitos normais. O diagnóstico mais provável é:

A) Esferocitose hereditária

B) Deficiência de G6PD

C) Anemia hemolítica autoimune a quente

D) Hemoglobinúria paroxística noturna

---

43 Mulher de 47 anos refere dispneia aos médios esforços há 5 meses. Teve febre reumática aos 10 anos, com artrite e sem sequela, e fez profilaxia com penicilina benzatina até os 21 anos; um ecocardiograma feito há 7 anos, para cirurgia de varizes, foi normal. Há 3 anos tem crises de orelhas vermelhas, dolorosas e inchadas, que poupam os lóbulos, e há 1 ano notou afundamento do dorso do nariz. Teve dois episódios de olho vermelho doloroso tratados com colírio de corticoide. PA 134 × 62 mmHg, FC 84 bpm, ritmo regular, pulmões limpos. Pavilhões auriculares espessados e amolecidos; nariz em sela. VHS 58 mm/h, FAN e ANCA negativos. A ausculta cardíaca mais provável nesta paciente é:

A) Sopro mesossistólico ejetivo com B2 hipofonética

B) Sopro holossistólico apical irradiado para a axila

C) Sopro diastólico aspirativo em borda esternal esquerda

D) Ruflar diastólico apical com estalido de abertura

---

44 Mulher de 34 anos, com epilepsia focal desde a adolescência, controlada há 6 anos com o mesmo comprimido de 400 mg duas vezes ao dia, que também lhe causou hiponatremia leve no início do uso. Não usa anticoncepcional (laqueadura há 3 anos). Procura avaliação por ganho de 9 kg em 2 anos, hipertensão recente e acne. Ao exame, IMC 33 kg/m², obesidade de predomínio abdominal, estrias brancas e finas no abdome, PA 146 × 92 mmHg, sem fraqueza proximal, sem equimoses espontâneas e sem pletora facial. Glicemia de jejum 108 mg/dL, potássio 4,2 mEq/L. Cortisol sérico às 8 horas após 1 mg de dexametasona às 23 horas da véspera: 6,8 µg/dL (normal: até 1,8). O próximo exame mais adequado é:

A) Cortisol salivar ao final da noite

B) Supressão com 8 mg de dexametasona

C) ACTH plasmático e ressonância de sela

D) Repetir a supressão com 1 mg

---

45 Mulher de 79 anos tem declínio progressivo de memória há 4 anos; hoje se perde no bairro, precisa de ajuda para administrar remédios e dinheiro, mas toma banho sozinha. MEEM 14 (escolaridade de 8 anos). RM de crânio com atrofia hipocampal bilateral, sem lesões vasculares relevantes. Teve dois episódios de síncope no último ano. Nega uso de betabloqueador, bloqueador de canal de cálcio, digital ou outra droga cronotrópica negativa. PA 136 × 80 mmHg, frequência cardíaca de 46 bpm. ECG: bradicardia sinusal, PR de 220 ms. Holter: pausas sinusais de até 2,8 s. TSH normal. A família pede tratamento para a demência. A droga mais adequada para iniciar é:

A) Donepezila em dose baixa

B) Rivastigmina transdérmica

C) Galantamina de liberação prolongada

D) Memantina

---

46 Mulher de 35 anos, com lúpus eritematoso sistêmico há 6 anos (artrite, fotossensibilidade e leucopenia ao diagnóstico), usa hidroxicloroquina 400 mg/dia e está assintomática há 2 anos, sem corticoide. Em consulta de rotina, o anti-DNA nativo subiu de 1:40 para 1:320, C3 68 mg/dL (90 a 180), C4 9 mg/dL (10 a 40). Exame físico normal, PA 118 × 72 mmHg, sem edema, sem lesões cutâneas, mucosas ou articulares. Hemograma normal, creatinina 0,7 mg/dL, urina tipo 1 sem hematúria, leucocitúria ou cilindros, relação proteína/creatinina urinária de 0,08. A conduta mais adequada é:

A) Prednisona 0,5 mg/kg/dia

B) Associar micofenolato de mofetila

C) Manter a hidroxicloroquina e reavaliar

D) Indicar biópsia renal

---

47 Homem de 67 anos, hipertenso há 20 anos, com creatinina de 1,2 mg/dL há 1 ano, é encaminhado com creatinina de 3,4 mg/dL e diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva. Refere cansaço e lombalgia mecânica há 3 meses, sem anti-inflamatórios. PA 138/84 mmHg, sem edema. Hemoglobina 9,6 g/dL, cálcio 10,4 mg/dL, albumina 3,8 g/dL. Fita urinária com proteína em traço, sedimento sem hematúria. Proteinúria de 24 horas de 3,6 g, com relação albumina/creatinina urinária de 52 mg/g. Ultrassonografia com rins de 11 cm, sem hidronefrose. O próximo exame mais adequado é:

A) Doppler das artérias renais

B) Relação proteína/creatinina repetida

C) Biópsia renal percutânea

D) Cadeias leves livres e imunofixação

---

48 Homem de 33 anos, vivendo com HIV, reiniciou há 3 semanas tenofovir, lamivudina e dolutegravir após 1 ano de abandono (CD4 de 170 células/mm³), junto com sulfametoxazol-trimetoprima profilático. Há 10 dias surgiram placas eritematoacastanhadas descamativas no tronco, nas palmas e nas plantas, placas esbranquiçadas na mucosa oral e queda de cabelo em clareiras. Afebril, com linfonodos epitrocleares palpáveis. ALT 118 U/L, fosfatase alcalina 690 U/L (referência até 120), bilirrubinas normais; eosinófilos 180/mm³. Teste rápido treponêmico reagente; VDRL não reagente, processado apenas na amostra pura. O próximo exame mais adequado é:

A) Biópsia cutânea com histopatologia

B) VDRL com diluições seriadas do soro

C) VDRL no líquor por punção lombar

D) Biópsia hepática percutânea

---

49 Mulher de 56 anos, não tabagista, com artrite reumatoide soropositiva há 12 anos, em uso de metotrexato 20 mg/semana há 8 anos, refere dispneia progressiva aos esforços há 1 ano, com tosse seca. Ausculta com raros grasnidos expiratórios, sem estertores em velcro. Espirometria: VEF1 48% do previsto, CVF 61%, VEF1/CVF 0,58, sem resposta ao broncodilatador. Pletismografia: CPT 104% do previsto, VR 192% do previsto, VR/CPT 0,62. DLCO 82% do previsto. TC de alta resolução: atenuação em mosaico, que se acentua na expiração, com espessamento de paredes brônquicas, sem reticulado, sem faveolamento e sem vidro fosco. O distúrbio funcional e a lesão mais provável são:

A) Misto / pneumopatia intersticial e bronquiolite

B) Obstrutivo com aprisionamento / bronquiolite constritiva

C) Restritivo / pneumonite por metotrexato

D) Restritivo / pneumopatia intersticial da artrite

---

50 Mulher de 36 anos, assintomática, não tabagista, sem hipertensão, diabetes ou dislipidemia, sem história familiar de doença coronariana precoce, fez teste ergométrico exigido por uma academia. Atingiu 11 METs e 96% da frequência cardíaca máxima prevista, sem dor torácica, sem queda da pressão e sem arritmias. No pico do esforço houve infradesnivelamento horizontal do segmento ST de 1,5 mm em V5 e V6, que se normalizou no primeiro minuto da recuperação. ECG de repouso normal. Sobre esse resultado, isoladamente, é correto afirmar que ele:

A) Confirma isquemia miocárdica

B) Indica cineangiocoronariografia

C) Tem baixo valor preditivo positivo

D) Exige angiotomografia coronariana

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado R01

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										